Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Antônio da Patrulha

Rua Roberto Xavier da Luz, 06 - Bairro: Cidade Alta - CEP: 95500000 - Fone: (51)3098-5792 - Balcão Virtual: 051.997816408 - Email: frsantantp2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001082-52.2022.8.21.0065/RS

AUTOR: CLOVIS GOMES SALAZAR

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

CLOVIS GOMES SALAZAR ajuizou *ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada* em face da **UNIMED PORTO ALEGRE**. Requereu, preliminarmente, prioridade na tramitação do feito, referindo que envolve direito de pessoa portadora de doença grave e que conta com 73 anos. No mérito, narrou ser beneficiário do plano de assistência à saúde operado pela requerida. Aduziu que, em razão do diagnóstico de Amiloidose Cardíaca, necessita fazer uso do medicamento Tafamidis Meglumina 80MG, na forma comercial Vyndaqel, que foi negado pela requerida, sob o argumento de que o medicamento não está previsto no rol de procedimentos da ANS. Discorreu que necessita do tratamento e não possui condições de custeá-lo. Teceu sobre o direito. Pleiteou a inversão do ônus da prova. Requereu a concessão da tutela de urgência. Ao final, pugnou pelo julgamento de procedência, para o fim de condenar a requerida a custear o medicamento Tafamidis Meglumina/Vyndaqel 80 mg, na quantidade de 4 (quatro) comprimidos ao dia. Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça (evento 1, INIC1). Juntou documentos (Evento 01).

Recebida tacitamente a inicial, foi deferida a inversão do ônus probante, negada a tutela de urgência e determinada a citação (evento 3, DESPADEC1).

Citada (evento 11, AR1), a requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol da ANS é taxativo, o que torna legítima a atuação da requerida e em conformidade com as diretrizes da agência reguladora. Sustentou que apenas é obrigatória a cobertura de medicamentos domiciliares para tratamento de câncer e de internação domiciliar, o que não é o caso do autor. Alegou que deve ser respeitado o acordo de vontades celebrado entre as partes. Ao final, requereu o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial (evento 14, CONT1).

Houve réplica (evento 18, RÉPLICA1).

Instadas (evento 20, DESPADEC1), a requerida informou que não pretendia produzir outras provas (evento 25, PET1), ao passo que o autor deixou transcorrer *in albis* o prazo para manifestação (Evento 26).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir, atenta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC.

Considerando os limites a que se restringiu a controvérsia, dispensável a produção de outros meios de prova, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, no estado em que se encontra o processo (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

A pretensão da parte autora é de que a requerida seja obrigada a custear o medicamento Tafamidis Meglumina/Vyndaqel 80 mg, em face do diagnóstico de Amiloidose Cardíaca que acomete o autor, conforme indicado pela médica no evento 1, LAUDO8.

A requerida, por sua vez, referiu que o medicamento não consta no rol de coberturas obrigatórias dispostas nas Instruções Normativas 065 da Resolução Normativa 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, para pacificar tal orientação, o Égrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 469, cujo teor é o seguinte:

Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Nesta conjectura, prevê o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que as *"cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"*.

Da mesma forma, ao caso, se aplica o previsto no art. 51, IV e o seu §1°, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

(...)

Por outro lado, os planos de saúde podem, apenas, estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento a ser prescrito, incumbência que pertence ao profissional da medicina que acompanha o paciente.

Ainda, a Lei n.º 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde estabelece em seu art. 10 o seguinte:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

(...)

No caso, o parecer técnico elaborado pelo Dr. André Antunes Poitevin expôs que, como a medicação prescrita não é para tratamento oncológico ambulatorial, agiu de acordo com a legislação a parte requerida (evento 14, PARECER4).

Nesta toada é o parecer técnico n.º 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, quando refere que é obrigatória a cobertura para **a)** medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso; **b)** medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual; e, **c)** medicamentos que eventualmente constem em contrato ou aditivo contratual acordado entre as partes (evento 14, PARECER5).

Todavia, no caso, inexiste previsão contratual quanto ao fornecimento do medicamento em questão. Pelo contrário, basta uma análise para verificar a expressa exclusão do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. Veja-se (evento 14, CONTR2 - pág. 35):

III. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES

A. Disposições Gerais

Cláusula 13: Estão expressamente excluídos deste contrato, não gerando direito a qualquer tipo de cobertura, sem prejuízo das limitações previstas nas cláusulas subseqüentes:
I. em todos os serviços oferecidos conforme o presente contrato:
a) tratamentos clínicos e cirúrgicos experimentais;
b) procedimentos clínicos, cirúrgicos, órteses e próteses para fins estéticos;
c) inseminação artificial;
d) tratamentos de rejuvenescimento ou emagrecimento com finalidade estética;
e) fornecimento de materiais e medicamentos estrangeiros, ou que não estejam nacionalizados, desde que tenha um similar nacional, bem como de todo e qualquer tipo de medicamento para tratamento domiciliar;

Desse modo, o plano de saúde não está obrigado a fornecer medicamentos para uso domiciliar, exceto os antineoplásicos orais ou medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, salvo disposição contratual.

Observe-se que, em caso paradigma, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a licitude da exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásticos orais, a medicação assistida e os incluídos no rol da ANS para esse fim:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. ***1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.*** *Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos*

profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. ***3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim.*** *4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.883.654 - SP. Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Data do julgamento 08 de junho de 2021) Grifei*

Nesta linha também é a jurisprudência do TJ/RS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. OMALIZUMABE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA PREVISÃO NO ROL. AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. 1) Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula o fornecimento do medicamento Omalizumabe 150mg, para o seu tratamento de asma, julgada improcedente na origem. ***2) A Resolução Normativa nº 465/2021 exarada pela ANS, está em consonância com o disposto no art. 10 da Lei nº 9.656/98, no que refere às exclusões de cobertura das operadoras de plano de saúde, isto é, são hipóteses excluídas, expressamente, pela lei de referência, salvo, é claro, contratação especial e/ou inclusão pela Agência Reguladora. 3) Não há ilegalidade na negativa de cobertura de medicamento para uso em ambiente externo ao de unidade de saúde, conforme artigo 17, inciso VI da Resolução Normativa nº 465/2021 exarada pela ANS, bem como o disposto no artigo 10 da Lei nº 9.656/98, à exceção dos antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.*** *4) Contudo, o remédio receitado (Omalizumabe 150mg) não atende a nenhuma das exceções que poderiam fundamentar a responsabilidade da associação em fornecer o medicamento, seja por não ser classificado como neoplásico, seja por ser administrado no ambiente domiciliar. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50287540920178210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 14-12-2023) Grifei*

Por conseguinte, depreende-se que não é ilícita a negativa da parte requerida no fornecimento do medicamentos de uso domiciliar, uma vez que está expressamento prevista sua exclusão no contrato firmado entre as partes, bem como amparada pela legislação vigente e entendimento jurisprudencial.

Assim, a improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos propostos por **CLOVIS GOMES SALAZAR** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE**.

Outrossim, confirmo a decisão do evento 3, DESPADEC1.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, forte no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Resta, contudo, suspensa a exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade da justiça (evento 3, DESPADEC1).

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Agendada intimação das partes.

Oportunamente, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA FURLAN TEIXEIRA, Juíza de Direito**, em 30/8/2024, às 19:8:4, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10055684816v164** e o código CRC **4cdbc6b8**.